노쇠가 의심될 때 선별에서 중재로

수치가 잘 조절돼도 기능·약물·영양·돌봄을 다시 봅니다

선별 결과를 다음 평가에 연결

CFS 선별 · 1~9점
보행과 ADL/IADL 질문

4점: 전노쇠
기능 변화·결핍 파악
예방과 중재

5점 이상: 노쇠
고위험 → CGA
결핍 영역별 중재

기능을 먼저 묻는 초진 기록

평가 항목	기록
보행·보조기구 · 최근 낙상 · 체중 감소	_____
기본 일상생활(ADL) 도움	_____
도구적 일상생활(IADL) 도움	_____
CFS 점수 · 기능 변화 · 주된 불편	_____

4·5·6점 경계를 질문으로 구분

연자는 ADL 장애가 있으면 CFS **6~7점**, ADL은 유지되나 IADL에 문제가 있으면 **5점**으로 설명했습니다. 보행 상태와 함께 구체적인 도움 필요 영역을 묻습니다.

CGA에서 확인할 결핍

- ☐ 질병·다약제: CNS 활성 약물·항콜린 부담·복용 시간
- ☐ 인지·우울·정서, ADL/IADL·신체활동
- ☐ 영양·체중·식사, 사회적 지지·돌봄 자원

평가 자체보다 중재가 목적

Frailty index(FI)

이상이 있는 변수 수 ÷ 전체 평가 변수 수. **30개 이상**의 인자를 구성하며, 강의 예시는 **10/40=0.25**, FI **≥0.25**를 노쇠로 설명했습니다. CGA가 가능한 곳에 연결해 결핍 영역과 중재 계획을 구체화합니다.

문제 영역	우선 조치 · 연결 담당
_____	_____
_____	_____

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
아산 28회 연수강좌 — 왜 이 환자는 계속 안 좋아질까? 개원의가 시작하는 노인 통합돌봄(백지연)

노쇠 중재 · 돌봄 연결 기록

상세 · 약물·영양·기능·사회적 자원을 함께 보완

다약제 점검

위험 약제군	실무 확인
항콜린제 · 항경련제 · 항정신병약 Benzodiazepine · Z-drug 항우울제(TCA·SSRI·SNRI) · opioid	약물 전체 목록과 복용 시간 검토 **CNS 활성 약물 3종 이상**이면 섬망·낙상 위험을 강조

강의 증례의 중재를 읽는 법

반복 낙상·어지럼·인지 저하 + 저체중·독거

연자는 benzodiazepine 주간 용량 감량, trazodone 아침→밤 변경, 불필요한 항콜린 약 조정, solifenacin→β_3작용제 변경을 시도했습니다. 이 증례에서는 추가 이득이 없다고 판단한 SGLT2 억제제를 DPP4 억제제로 바꾸고, 경구영양보충제(ONS)를 **하루 2회** 처방했습니다.

위 내용은 증례에서 선택한 중재입니다. 환자별 적응증·효과·기능·영양을 함께 보고 조정합니다.

CGA가 가능한 환경에 따라 연결합니다

정밀평가로 결핍과 중재를 구체화

강의 흐름도는 노쇠 선별 후 CGA가 가능한 환경이면 기능·신체 건강·인지/정신·동반질환/다약제·사회경제적 상황을 평가해 FI를 산출하는 경로를 제시했습니다.

CGA가 어려운 환경의 신체 노쇠 평가	확인할 단서
Exhaustion · Slowness	탈진 · 느린 보행
Low physical activity · Weakness	낮은 신체활동 · 근력 저하
Weight loss	체중 감소

강의는 부담이 큰 치료를 앞두거나 임상적으로 고위험인 노인도 노쇠 평가에 연결했습니다. 선별 점수만 매기기보다 중재할 결핍 영역을 찾는 것이 목적입니다.

돌봄 연결과 재평가

상세 · 서비스 연계와 기능 변화의 기록

의료와 돌봄을 함께 연결

복합 지원 필요 파악
노쇠 · 일상생활 곤란

→

읍면동 · 건보공단 신청
조사 → 개인별 지원계획

→

서비스 연계 · 모니터링
상태 변화에 맞춰 계획 조정

강의의 4대 영역	연결 예시
보건의료 · 건강관리	방문진료·퇴원 지원·치매/만성질환 관리 노쇠 예방·복약지도·운동 프로그램
장기요양 · 일상돌봄	방문요양·간호·목욕·주야간/단기보호 긴급돌봄·독거 안전·주거환경 개선

연계·재평가 기록

영역	조치·담당·다음 확인
약물 / 영양 / 보행·낙상	_____
인지·정서 / 일상생활 / 돌봄	_____
연계 기관 · 담당자 · 재평가일	_____

재평가할 변화

어지럼·낙상·식사량·활동량, 체중·CFS·신체기능·영양을 다시 봅니다. 강의 증례는 **4주 후** 재진에서 호전되었습니다. CFS **5~6점**에서는 장기요양·통합돌봄 필요성을 살피되, 보험 등급은 신청·판정 절차로 연결합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/geriatrics/frailty-screen-intervention-card/